

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Revisão Flash • SESSÃO 12

Cirurgia Pediátrica

O essencial para a prova em uma página



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º PERÍODO • 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR • *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Cirurgia pediátrica

Leitura de 5 minutos

EM UMA FRASE

Vômito verde é obstrução até prova em contrário; estabilize (água, calor, glicose, sonda) antes do exame, escolha o exame que muda a conduta e saiba o que é emergência e o que é cirurgia programada.

- | | |
|---|--|
| <p>1 Vômito bilioso no RN: pensar em má rotação com volvo; instável vai direto para a cirurgia.</p> | <p>2 Piloro: 2–8 semanas, jato não bilioso, alcalose; corrigir antes de operar.</p> |
| <p>3 Dupla bolha: atresia duodenal, síndrome de Down.</p> | <p>4 Intussuscepção: ultrassom (alvo) e redução por enema; peritonite = cirurgia.</p> |
| <p>5 Mecônio após 48 h: investigar obstrução (Hirschsprung; biópsia retal).</p> | <p>6 Fezes claras: bilirrubina direta e Kasai o quanto antes.</p> |
| <p>7 Hérnia diafragmática: sem máscara; intubar e sonda gástrica.</p> | <p>8 Orquidopexia até 12–18 meses; hérnia inguinal se opera, umbilical se observa.</p> |

PAREDE ABDOMINAL

	GASTROSQUISE	ONFALOCELE
<i>Local</i>	À direita	Central
<i>Saco</i>	Não	Sim
<i>Anomalias</i>	Atresia	Muitas

PEGADINHA

Fimose fisiológica não se opera. Hipospádia não se circuncida. Parafimose é urgência.

CHECKLIST ANTES DA PROVA

- ☐ Separo vômito bilioso de não bilioso
- ☐ Sei o preparo do piloro
- ☐ Reconheço intussuscepção e sei reduzir
- ☐ Sei rastrear atresia de vias biliares
- ☐ Diferencio gastrosquise e onfalocele
- ☐ Sei a sala de parto da hérnia diafragmática
- ☐ Sei quando operar hérnia e testículo